STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Podmiot leczniczy: Centrum Ortopedyczne OrthoCare Sp. z o.o. | ul. Dębowa 2, 26-600 Radom

§ 1. Cel, podstawa prawna i zakres

1. Celem Standardów jest zapobieganie krzywdzeniu dzieci, wczesne rozpoznawanie sygnałów zagrożenia i zapewnienie bezpiecznej reakcji, z poszanowaniem praw pacjenta i tajemnicy medycznej.

2. Podstawę stanowią w szczególności art. 21 oraz art. 22b–22c ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i ochronie danych.

3. Standardy obowiązują Zarząd, Prokurenta, pracowników oraz osoby wykonujące zadania na rzecz OrthoCare na każdej podstawie prawnej, w zakresie ich kontaktu z dziećmi.

4. Placówka nie prowadzi monitoringu wizyjnego ani teleporad; standardy nie deklarują usług psychologicznych ani anonimowych formularzy, których faktycznie nie udostępniono.

§ 2. Pojęcia i odpowiedzialność

1. Małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 lat. Krzywdzenie – działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobro dziecka, w szczególności przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie lub narażenie na przemoc.

2. Zarząd Spółki i Prokurent uczestniczą w bieżącym zarządzaniu podmiotem na równych zasadach organizacyjnych, z poszanowaniem kompetencji ustawowych i zasad reprezentacji spółki. Nie tworzy się dodatkowego stanowiska kierownika placówki.

3. Zgłoszenia przyjmują Zarząd lub Prokurent (dalej: osoba przyjmująca zgłoszenie); dane kontaktowe i sposób kontaktu udostępnia się w rejestracji i na stronie internetowej. Jeżeli podejrzenie dotyczy jednej z tych osób, zgłoszenie przyjmuje druga z nich; jeżeli dotyczy obu – członek personelu zawiadamia bezpośrednio właściwe organy.

4. Za przygotowanie personelu do stosowania Standardów, dokumentowanie zapoznania z nimi, prowadzenie rejestru i okresowy przegląd odpowiadają Zarząd i Prokurent; mogą organizacyjnie powierzyć czynności pomocnicze upoważnionemu pracownikowi, bez tworzenia odrębnego organu. Przygotowanie personelu obejmuje przekazanie Standardów, omówienie zasad rozpoznawania krzywdzenia, sposobów zgłaszania podejrzeń, zasad interwencji oraz potwierdzenie zapoznania się z dokumentem.

§ 3. Bezpieczne relacje personelu z dzieckiem

1. Każdemu dziecku zapewnia się życzliwe, spokojne i niedyskryminujące traktowanie. Personel przedstawia się, wyjaśnia cel i przebieg badania językiem dostosowanym do wieku, dojrzałości i potrzeb małoletniego, uwzględniając niepełnosprawności i trudności w komunikacji.

2. Kontakt fizyczny jest dopuszczalny, gdy służy badaniu, leczeniu, zapewnieniu bezpieczeństwa lub innemu prawnie uzasadnionemu celowi; jest ograniczony do niezbędnego zakresu. Przed odsłonięciem ciała personel wyjaśnia potrzebę i zapewnia intymność.

3. Personel respektuje prawo dziecka do obecności osoby bliskiej zgodnie z prawem pacjenta, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych. Nie ustanawia się bezwzględnego wymogu obecności rodzica przy każdym badaniu; kwestie zgody na świadczenie podlegają odrębnym przepisom, w tym zasadom współdecydowania pacjenta od ukończenia 16 lat.

4. Zabronione są: uderzanie, szarpanie, zastraszanie, poniżanie, komentarze seksualne, nieuzasadnione dotykanie, utrwalanie wizerunku bez podstawy prawnej, udostępnianie danych dziecka osobom nieuprawnionym oraz prywatne kontakty z małoletnim wykraczające poza cel świadczenia.

5. Personel nie przyjmuje od dziecka sekretu, którego zachowanie mogłoby narażać je na krzywdę; w sposób dostosowany do wieku tłumaczy potrzebę przekazania informacji osobom mogącym udzielić pomocy.

6. Nie wolno izolować dziecka jako kary ani stosować przymusu poza przypadkami i trybem przewidzianymi prawem.

§ 4. Bezpieczne relacje pomiędzy małoletnimi

1. W poczekalni i innych pomieszczeniach zabronione są groźby, bicie, wyśmiewanie, przemoc seksualna, fotografowanie lub nagrywanie innego dziecka bez uprawnienia oraz rozpowszechnianie poniżających treści.

2. Personel, który dostrzeże naruszenie, przerywa je w granicach bezpieczeństwa, rozdziela uczestników, udziela niezbędnej pomocy i informuje osoby odpowiedzialne; w razie potrzeby kontaktuje się z opiekunami, o ile nie zagraża to dziecku.

3. Działania wobec dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami dobiera się indywidualnie, z uwzględnieniem ich sposobu komunikacji i potrzeb.

§ 5. Internet i treści szkodliwe

1. Urządzenia elektroniczne należące do placówki służą wykonywaniu obowiązków; personel nie udostępnia małoletnim urządzeń służbowych bez uzasadnionej potrzeby i nadzoru.

2. Jeżeli małoletni korzysta z własnego urządzenia, personel nie kontroluje prywatnej korespondencji bez podstawy prawnej; reaguje na ujawnione zagrożenie w granicach swoich kompetencji.

3. W razie ujawnienia treści seksualnych, przemocy, cyberprzemocy, nakłaniania do samookaleczeń lub kontaktów z osobą podejrzaną personel zapewnia bezpieczeństwo dziecka, nie rozpowszechnia materiału, zabezpiecza niezbędne informacje zgodnie z prawem i uruchamia procedurę interwencji.

4. Jeżeli placówka udostępni pacjentom sieć Wi-Fi lub urządzenia z Internetem, zapewnia adekwatne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne oraz zasady ich korzystania; przed uruchomieniem takiej usługi aktualizuje Standardy.

§ 6. Rozpoznawanie zagrożeń i przyjmowanie zgłoszeń

1. Niepokojące sygnały mogą obejmować obrażenia o niewyjaśnionym pochodzeniu, niespójne wyjaśnienia, lęk przed opiekunem, oznaki zaniedbania, ujawnienie przemocy, zachowania seksualizowane lub wyraźne zmiany zachowania. Żaden pojedynczy sygnał nie przesądza o krzywdzeniu.

2. Osoba, która zauważy sygnał, wysłuchuje dziecka bez sugerowania odpowiedzi, ocenia bezpieczeństwo, w razie potrzeby udziela pomocy medycznej i niezwłocznie informuje Zarząd albo Prokurenta.

3. Zgłoszenie można złożyć osobiście w rejestracji lub pisemnie na adres placówki, e-mailem: administracja@orthocare-radom.pl, a w przypadku pilnego zagrożenia bezpośrednio do Policji lub służb ratunkowych. Zgłoszenie może złożyć dziecko, osoba bliska lub pracownik.

4. Każde zgłoszenie dokumentuje się w Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 2), ograniczając dane do niezbędnych. Informację przekazuje się wyłącznie osobom uprawnionym. Nie obiecuje się bezwarunkowej anonimowości ani całkowitej poufności.

§ 7. Procedura interwencji

1. Jeżeli istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo życia lub zdrowia – należy niezwłocznie udzielić pomocy, wezwać 112 oraz postępować według zaleceń służb. Zawiadomienie kierownictwa nie może opóźniać pomocy.

2. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka Zarząd lub Prokurent organizuje zawiadomienie Policji albo prokuratury. Obowiązki zawiadomienia wynikające bezpośrednio z przepisów dotyczą również osób, na których ciążą; nie czekają one na decyzję przełożonego.

3. Gdy dobro dziecka jest zagrożone w środowisku rodzinnym, rozważa się zawiadomienie sądu opiekuńczego (wniosek o wgląd w sytuację rodziny), a przy podejrzeniu przemocy domowej – uruchomienie procedury „Niebieskie Karty" przez uprawnioną osobę zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka personelu, osoba odpowiedzialna niezwłocznie zapewnia dziecku bezpieczeństwo, może odsunąć tę osobę od kontaktu z dziećmi na czas wyjaśniania w granicach prawa i wdraża odpowiednie zawiadomienia. Nie prowadzi samodzielnego śledztwa ani konfrontacji dziecka ze wskazaną osobą.

5. Jeżeli osobą podejrzewaną jest rodzic/opiekun, nie przekazuje się mu automatycznie informacji o zgłoszeniu, jeżeli mogłoby to narazić dziecko; sposób komunikacji ustala się z uwzględnieniem bezpieczeństwa i wymagań prawa.

6. Z przebiegu interwencji sporządza się Kartę interwencji (Załącznik nr 3). Dane medyczne związane z leczeniem dokumentuje się niezależnie w dokumentacji medycznej. Dokumentacja ochrony małoletnich jest przechowywana w ograniczonym dostępie.

§ 8. Plan wsparcia małoletniego

1. Po ujawnieniu krzywdzenia Zarząd lub Prokurent, we współpracy z personelem mającym kontakt z dzieckiem, określa adekwatny i proporcjonalny plan bezpieczeństwa i wsparcia (Załącznik nr 4).

2. Plan może obejmować: zapewnienie pilnej pomocy medycznej, wskazanie bezpiecznej osoby do kontaktu, informację o instytucjach wsparcia, organizację dalszej konsultacji, sposób bezpiecznego przekazania informacji opiekunowi oraz ustalenie terminu weryfikacji.

3. OrthoCare nie deklaruje prowadzenia opieki psychologicznej we własnym zakresie; jeżeli jest wskazana, informuje o odpowiednich zewnętrznych formach wsparcia.

4. Dziecko i jego opiekuna informuje się o działaniach w zakresie bezpiecznym i prawnie dopuszczalnym.

§ 9. Weryfikacja przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi

1. Przed zatrudnieniem lub dopuszczeniem osoby do działalności związanej z leczeniem małoletnich przeprowadza się weryfikację określoną w art. 21 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków. Dotyczy to również osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B, jeśli wykonują czynności objęte przepisem.

2. Podmiot sprawdza odpowiednie rejestry wskazane w art. 21; osoba dopuszczana przedstawia wymagane informacje z KRK i, gdy dotyczy, dokumenty lub oświadczenia dotyczące obywatelstwa i zamieszkiwania za granicą. Zakres dokumentów należy ocenić indywidualnie zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy.

3. Potwierdzenia weryfikacji przechowuje się w aktach lub odrębnej, odpowiednio zabezpieczonej dokumentacji. Brak wymaganej weryfikacji przed dopuszczeniem nie może być zastępowany samym podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się ze Standardami.

§ 10. Przygotowanie personelu i przechowywanie dokumentacji

1. Zarząd i Prokurent odpowiadają za przekazanie Standardów personelowi przed rozpoczęciem zadań związanych z kontaktem z dziećmi, wyjaśnienie zasad rozpoznawania sygnałów, zgłaszania i interwencji oraz wskazanie kanałów kontaktu.

2. Zapoznanie dokumentuje się podpisanym potwierdzeniem. W przypadku istotnych zmian przeprowadza się ponowne zapoznanie personelu.

3. Zgłoszenia, karty interwencji i plany wsparcia ujmuje się w Rejestrze zdarzeń (Załącznik nr 5). Rejestr jest przechowywany odrębnie od danych dostępnych pacjentom, a dokumenty incydentów w zamkniętym miejscu lub chronionym zasobie elektronicznym, z dostępem ograniczonym do upoważnionych.

4. Dokumentację przechowuje się przez okres wynikający z właściwych przepisów i zasad retencji przyjętych przez administratora, nie dłużej niż to konieczne; w przypadku postępowań – z uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia dowodów.

5. Personel zachowuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.

§ 11. Udostępnienie i przegląd

1. Standardy udostępnia się na stronie internetowej OrthoCare oraz wywiesza w widocznym miejscu w placówce, zarówno w wersji pełnej, jak i skróconej dla dzieci (Załącznik nr 1).

2. Wersję skróconą sporządza się w przystępnej formie dla dzieci i nastolatków; personel pomaga się z nią zapoznać również osobom z trudnościami komunikacyjnymi.

3. Nie rzadziej niż raz na dwa lata Zarząd i Prokurent dokonują pisemnej oceny adekwatności Standardów i dokumentują wnioski (Załącznik nr 6). Dodatkowy przegląd następuje po istotnym incydencie, zmianie przepisów albo organizacji działalności.

4. Standardy przyjmuje i zmienia podmiot zgodnie z zasadami kompetencji i reprezentacji spółki. Data wejścia w życie zostaje wskazana w zatwierdzonym egzemplarzu.

Zatwierdzono dnia: .....

Podpis osoby/osób uprawnionych: .....

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WERSJA SKRÓCONA DLA DZIECI

JESTEŚ W ORTHOCARE. MASZ PRAWO CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE.

Możesz pytać, co będzie działo się podczas badania. Lekarz powinien wyjaśnić Ci to zrozumiale.

Masz prawo do szacunku, prywatności i ochrony przed przemocą.

Nikt nie może Cię bić, straszyć, obrażać ani dotykać w sposób niezwiązany z badaniem.

Jeżeli coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, powiedz lekarzowi, pielęgniarce, osobie w rejestracji albo zaufanej osobie dorosłej.

Możesz zgłosić problem w rejestracji OrthoCare, ul. Dębowa 2 w Radomiu, lub napisać: administracja@orthocare-radom.pl.

Jeżeli jesteś w niebezpieczeństwie – dzwoń 112. Możesz także skorzystać z telefonu zaufania dla dzieci 116 111.

Twoje zgłoszenie potraktujemy poważnie. Jeśli będzie trzeba, zwrócimy się do osób i służb, które mogą zapewnić Ci ochronę.

WERSJĘ PEŁNĄ STANDARDÓW możesz przeczytać w rejestracji i na stronie internetowej OrthoCare.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO

Numer sprawy: ..... Data i godzina przyjęcia: .....

Pole	Informacje
Dane dziecka / identyfikator sprawy	.....
Osoba zgłaszająca i kontakt (o ile podano)	.....
Osoba przyjmująca	.....
Miejsce, czas i okoliczności zdarzenia	.....
Zaobserwowane fakty / objawy / wypowiedzi dziecka (możliwie dosłownie)	.....

Czy istnieje pilne zagrożenie? Podjęta pomoc	.....
Komu i kiedy przekazano zgłoszenie?	.....
Dokumenty / materiały załączone	.....

Podpis osoby przyjmującej: ..... Data: .....

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA INTERWENCJI

Numer sprawy: ..... Data rozpoczęcia: .....

Element	Opis
Podstawa podjęcia interwencji	.....
Ocena pilnego zagrożenia i pierwsze działania	.....
Działania zabezpieczające i medyczne	.....
Kontakt z opiekunem – czy bezpieczny?	.....
Zawiadomienie Policji / prokuratury (kiedy, kto, sygnatura)	.....
Zawiadomienie sądu opiekuńczego / Niebieskie Karty (jeśli dotyczy)	.....
Osoby odpowiedzialne, daty działań	.....
Dalsze ustalenia / zamknięcie sprawy	.....

Osoba sporządzająca: ..... Podpis: .....

ZAŁĄCZNIK NR 4 – INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA I BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

Numer sprawy: ..... Data sporządzenia: .....

Obszar	Ustalenia
Najpilniejsze potrzeby i zagrożenia	.....
Bezpieczna osoba kontaktowa dla dziecka	.....
Pomoc medyczna / skierowanie	.....
Zewnętrzne instytucje wsparcia	.....
Sposób bezpiecznego kontaktu z opiekunem	.....
Działania, terminy i osoby odpowiedzialne	.....
Termin przeglądu planu i wynik	.....

Opracował(a): ..... Zatwierdził(a): .....

ZAŁĄCZNIK NR 5 – REJESTR ZGŁOSZEŃ I INTERWENCJI

Rejestr prowadzony w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych; zamiast pełnych danych dziecka można używać numeru sprawy.

Nr	Data	Identyfikator sprawy	Rodzaj zgłoszenia	Działania / organ	Status

ZAŁĄCZNIK NR 6 – PROTOKÓŁ OKRESOWEJ OCENY STANDARDÓW

Data oceny: ..... Osoby dokonujące oceny: .....

Zakres	Ustalenia / działania
Czy dokument odpowiada aktualnemu prawu i organizacji?	.....
Czy wersja pełna i skrócona są dostępne w placówce i online?	.....
Czy personel jest zapoznany ze Standardami i weryfikowany przed dopuszczeniem?	.....
Czy od ostatniej oceny wystąpiły incydenty i jakie wnioski z nich wynikają?	.....
Potrzebne korekty / osoba odpowiedzialna / termin	.....
Data następnego przeglądu (maks. 2 lata)	.....

Podpisy: .....

Źródła prawne: ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 110, z późn. zm.); art. 21 i art. 22b–22c; ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.